
PRE Y POST OPERATORIO

El riesgo de una intervención quirúrgica

Es la probabilidad de morbilidad o mortalidad, que puede experimentar un paciente, como resultado de:

- La preparación preoperatoria (incluida la logística)**
- Del estado de salud del paciente previo a la cirugía.**
- De la anestesia.**
- De la intervención quirúrgica según el expertiz del Cirujano.**
- Del período posoperatorio.**

PROCEDENCIA DEL PACIENTE QUIRÚRGICO

Cirugía de Emergencia

Consulta externa (Cirugía programada)

Cirugía ambulatoria

Transferencia

Pre operatorio

Conjunto de acciones que el cirujano debe adoptar cuando se halla frente a un paciente con una patología quirúrgica o que potencialmente podría requerir manejo quirúrgico.

Objetivos del pre operatorio

- 1.- Evitar y disminuir la morbilidad quirúrgica**
- 2.- Facilitar su recuperación**
- 3.- Reincorporación pronta, a sus actividades cotidianas.**
- 4.- Disminuir costos; tanto, para el paciente como para la institución.**

Como lograr los objetivos del pre operatorio

1. Identificando y modificando los factores de riesgo

- 1. Confeccionando una adecuada historia clinica**
- 2. Examen clínico minucioso**
- 3. Exámenes complementarios**
- 4. Evaluación psicológica**

2. Planificando la anestesia

- 1. Evaluación previa por el anesthesiologo quien dará las recomendaciones del caso.**

3. Planificando la cirugía

- 1. Preparación del acto quirúrgico- recomendaciones pre op.**
- 2. Manejo de patologías pre-existentes**
- 3. Prevención de posibles complicaciones.**
- 4. Firma del consentimiento informado.**

4. Previendo el post operatorio

CONSULTA EXTERNA Para cirugía electiva

PRE OPERATORIO

Evaluación prequirúrgica general:

- Historia clínica minuciosa
- Exámen clínico completo

- Exámenes de laboratorio

Por
bioseguridad

Para evaluación
general

- Identificación de:
- hepatitis B, C
 - VIH
 - Lues
 - Otros

% de ayuda para el
diagnóstico

---- > 56 %

---- > 17 %

---- > 5 %

Para solicitar los exámenes auxiliares con fines diagnósticos; se debe conocer la verdadera importancia de ellos; su sensibilidad, especificidad y costos.

- Hemograma Completo
- Glucosa, urea, creatinina
- Perfil hepático
- Perfil de coagulación
- Grupo sanguíneo y factor
- Examen completo de orina

Riesgo quirúrgico Cardiovascular

Evaluación de los factores de riesgo CV:

- Edad
- Angina
- IMA
- ICC
- Trastornos de conducción
- Enf. Valvular
- Enf. Vascular periférica
- Tipo de procedimiento a realizar

Instrumentos:

HISTORIA CLINICA

EKG

ECOCARDIO

ECODOPPLER

OTROS

Elementos a tomar en cuenta para el score de Goldman

Historia	> de 70 años	5
Clinica	IMA en últimos 6 meses	10
Examen	3er RC o injurgitación yugular	11
Físico	Estenosis aórtica significativa	3
EKG	No ritmo sinusal	7
EKG	+ de 5 contracciones ventric	7
Mal Estado General		3
Cirugía a realizar	Abdomino peritoneal	3
Cirugía a realiar	Toraco pleural	3

Score riesgo		Complicacio- nes	muerte
Bajo	(0 – 5)	0.7 %	0.2 %
Significativo	(6 - 12)	5 %	2 %
Moderado	(13 - 25)	11 %	20 %
Alto	(mayor de 25)	22 %	56 %

Evaluación Neumológica

La Historia clínica completa, evaluar:

- **Edad**
- **EPOC**
- **Tabaquismo**
- **Obesidad**
- **Infecciones respiratorias agudas**
- **Estado nutricional**
- **Cuello corto**
- **Prognatismo – retrognatismo**
- **Limitación de apertura bucal (< de 35mm)**

Exámenes :

- **Rx de tórax**
- **Eco o tomografía según caso**
- **Gasometría arterial basal**
- **Pruebas de función pulmonar (espirometría)**

CLASIFICACION DE MALLAMPATI

CLASE I	Se observa paladar blando, úvula, pared posterior de faringe y los pilares
CLASE II	Solo se vé: Paladar blando, úvula y pared posterior de faringe
CLASE III	Solo se observa: Paladar blando y base de úvula
CLASE IV	No es posible ver ni aún el paladar blando

Evaluación de la hemostasia

Evaluar antecedentes de hemorragias y equimosis.

Tiempo de tromboplastina parcial activada

Tiempo de protrombina

Concentración de fibrinógeno

Recuento de plaquetas

Tiempo de sangría

Trombosis venosa y embolismo pulmonar.

Antecedentes de TVP

Tumores

Inmovilidad

Obesidad

ICC

Deficiencia de factor III

CONDUCTA

Profilaxis mecánica

- vendas elásticas

- movilización precoz

Heparina de bajo PM

Warfarina

Tratamiento trombolítico

Valoración Nutricional

Historia clínica:

- Estado general
- Enfermedades hipercatabólicas
- Disminución ponderal de 10% en los últimos 2 meses
- Hipoalbuminemia 3.3 mg/dl.
- Transferrina menor de 200 mg/dl.
- Linfocitopenia
- Pacientes con mas de 7 días de NPO
- Enfermedades crónicas, hipercatabólicas, cirugías previas
- Alteraciones gastrointestinales con trastornos de absorción

Necesidades Calóricas

Aporte calórico fijo diario: 1 Kcal/Kg/h ó 24 Kcal/Kg/día

Fórmula de Harris - Benedict :

$$\text{GEB (M)} = 65.5 + (9.6 * \text{peso}) + (1.8 * \text{Talla}) - (4.7 * \text{edad})$$

$$\text{GEB (V)} = 66.4 + (13.7 * \text{peso}) + (5.0 * \text{Talla}) - (6.7 * \text{edad})$$

GEB: (Gasto energético basal) ...energía necesaria para mantener las actividades vitales

El paciente quirúrgico

PACIENTE DE EMERGENCIA

Poco tiempo para su preparación
Mayor riesgo de perder la vida o
Complicación severa



Monitorizar al paciente

Signos de shock:

Reposición de volumen
Drogas vasoactivas
Empleo de corticoides
Antibióticos.

Signos de infección:

Hemocultivos
cultivo de secreciones y fluidos
antibiótico terapia de amplio espectro.



CONSENTIMIENTO INFORMADO
DOCUMENTO MÉDICO LEGAL



EVALUACIÓN ANESTESIOLÓGICA

CLASIFICACION DE MALLAMPATI

CLASE I	Se Observa paladar blando, úvula, pared posterior de faringe y los pilares
CLASE II	Se vé: Paladar blando, úvula y pared posterior de faringe
CLASE III	Solo se observa: Paladar blando y base de úvula
CLASE IV	No es posible ver ni aún el paladar blando

AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS PHYSICAL STATUS (ASA-PS)

Sistema de clasificación del estado físico perioperatorio según la American Society of Anesthesiologists

Calificación	Estado físico o clínico	Ejemplo de entidad nosológica
ASA 1	Paciente Sano Normal	
ASA 2	Paciente con enf. Sistémica leve	Asma moderada o hipertensión arterial bien controlada. Sin impacto en la actividad diaria. Poca probabilidad de impacto por cirugía o anestesia
ASA 3	Pte. Con enf. Sistémica grave	Falla renal o diálisis o insuficiencia cardíaca congestiva clase 2. HTA mal controlada, diabetes mellitus con complicaciones vasculares, enfermedad pulmonar crónica con limitación de actividad. Probable impacto con anestesia y cirugía
ASA 4	Pte. Grave con amenaza constante a su vida	Infarto agudo al miocardio, falla respiratoria que requiere ventilación mecánica. Falla cardíaca congestiva, angina pectoris inestable, enfermedad pulmonar, renal o hepática avanzada. Seria limitación de la actividad diaria. Impacto mayor por anestesia y cirugía
ASA 5	Pte. Moribundo no sobrevive sin la operación	Moribundo, con riesgo de muerte en las siguientes 24hs. aun sin cirugía. Hemorragia no controlada como aneurisma aorta abdominal, edema cerebral, embolia pulmonar.
ASA 6	Pte. Con muerte cerebral para retiro de órganos para donación.	

AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS PHYSICAL STATUS (ASA - PS)

En resumen:

ASA 1. Individuo sano

ASA 2. Enf. Sistémica leve-moderada sin limitación funcional

ASA 3. Enf. Sistémica severa con limitación funcional.

ASA 4. Enf. Sistémica severa que amenaza la vida del paciente

ASA 5. Moribundo con sobrevida menor a 24 horas con o sin cirugía

La clasificación ASA-PS es una evaluación preoperatoria del estado físico del paciente; por sí misma no es un predictor de riesgo quirúrgico.

El riesgo perioperatorio es el resultado de la combinación de:

- **El estado físico del paciente.**
- **La potencial agresión fisiológica que el procedimiento va a causar.**
Por ejemplo la restricción respiratoria o hemodinámica que causa una enteroscopia prolongada, respuesta a la bacteriemia de un drenaje coledociano, alteración del volumen de cierre respiratorio en un obeso o anciano durante colonoscopia larga.
- **La experiencia y habilidad del operador.**
- **La experiencia y habilidad del anestesiólogo (incluye la elección del tipo de anestesia).**
- **El soporte fisiológico durante el período pre y post-operatorio.**

Post operatorio

Fases del PO

Inmediato

**hasta las 6 horas, control de signos vitales
control del dolor**

Mediato

Recuperación de la movilidad y tolerancia digestiva

Tardío

**Desde su alta , hasta su reincorporación a sus
actividades cotidianas.**

Proceso que abarca desde finalizada la cirugía hasta que el paciente se recupere completamente y se incorpore a sus actividades cotidianas con o sin secuelas asociadas.

POSTOPERATORIO



**Manejo de herida, dolor posoperatorio
Venoclisis, catéteres, drenes, SNG,
sonda vesical, ostomías, inicio de via
oral.**

**Anticoagulación y medidas preventivas
del TEP, bloqueadores H2, uso de
antibióticos, líquidos y electrolitos**

Niveles de atención del postoperado

Si es cirugía ambulatoria

la recuperación es domiciliaria, debe asegurarse que una persona lo asista en la toma de sus medicación y esté previsto de acudir a emergencia en caso de presentar alguna complicación.

Evaluación diaria de funciones vitales, diuresis , drenajes y detección de eventuales complicaciones

Indicaciones:

Tipo de reposo y posición (con deambulacion precoz según el caso).

Régimen de alimentación pronta según tolerancia y cirugía realizada

Hidratación con líquidos y electrolíticos según su requerimiento,

Bloqueadores de secreción gástrica

Analgésicos,

Tromboprofilaxis

Antibióticos en forma terapéutica según el caso.

Si es cirugía con hospitalización

Si requiere Unidad de paciente crítico

Requiere monitorización y control estricto de su medio interno, son pacientes con complicaciones muy graves o cirugías complejas

MENSAJE FINAL

Si hacemos un buen manejo pre y post operatorio; nuestro arte quirúrgico, se verá reflejado en la satisfacción del paciente, engrandeciendo la nobleza de la cirugía.

Si un cirujano presume su arte sin estas consideraciones; su conciencia clamará por el cementerio que lleva a cuestas.